

PROY-NOM-045-SSA-2026

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO IAAS 2026

Fijaciones y Sujeciones Seguras

Prevención de lesiones e infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS)

Disposiciones clínicas actualizadas y requisitos específicos obligatorios aplicables a neonatos y menores de 1 año.

Contexto y Panorama Epidemiológico

3,389

CASOS DE IAAS (ENE-MAR 2026)
MENORES DE 1 AÑO (GRUPO ALTAMENTE
AFECTADO)

Distribución en Terapia Intensiva Neonatal (UTIN):

Predominan las **Infecciones del Torrente Sanguíneo Asociadas a Catéter Central (ITS-CC)** con un **32%** y la **Neumonía Asociada a Ventilador (NAV)** con un **21%**.

La relación directa: Una fijación inadecuada del dispositivo incrementa el riesgo de desplazamiento, manipulación innecesaria, infección, lesión cutánea o isquemia local.

** Cambio regulatorio principal: Se transita de indicaciones generales a requisitos específicos y obligatorios adaptados estrictamente al neonato.*

| Principios Rectores de Seguridad



Seguridad Clínica

La fijación debe aplicarse sin provocar tensión, compresión o daño tisular sobre la piel neonatal extremadamente sensible.



Materiales Aptos

Uso exclusivo de insumos hipoalergénicos, suaves y permeables. Queda estrictamente prohibido el uso de adhesivos rígidos o esparadrapo común.



Visibilidad y Retiro

El punto de inserción debe estar permanentemente a la vista. El retiro debe ser paralelo a la piel, sin tracción fuerte.



Registro Clínico

Es obligatorio documentar tipo de fijación, fecha, estado cutáneo y verificación periódica de la circulación distal.

Fijación de Tubo Endotraqueal y Cánulas

Meta principal: Impedir desplazamientos accidentales, evitar la presión nociva sobre zonas delicadas (narinas, labios) y prevenir la Neumonía Asociada a Ventilador (NAV).

- ✓ **Materiales:** Cintas elásticas sumamente suaves y uso de protectores cutáneos finos como barrera previa.
- ✓ **Fijación Bilateral:** Distribución simétrica del soporte, garantizando espacio suficiente (debe caber un dedo entre la cinta y la piel).
- ✓ **Circuitos Independientes:** El soporte de los circuitos debe ser autónomo para evitar vectores de tracción hacia el tubo.
- ✓ **Mantenimiento:** Revisar exhaustivamente cada turno; proceder al cambio cada 24-48 horas o de forma inmediata si está húmedo o sucio.



La posición de referencia (profundidad) debe marcarse siempre en la comisura labial.

| Catéteres Umbilicales

Sujeción de Alta Seguridad

Diseñado para mantener la posición óptima del catéter, evitar pliegues, migración y reducir a cero la tasa de infecciones del torrente sanguíneo.

Técnica de Puente: Fijación tipo "puente" levantado sobre el propio muñón umbilical. Queda estrictamente **prohibido** colocar adhesivos directamente sobre la piel periumbilical.

Antisepsia Rigurosa: Se autoriza de manera exclusiva el uso de **alcohol al 70%** en el área. Los compuestos yodados están contraindicados en neonatos por riesgo de absorción sistémica y toxicidad tiroidea.

** El sitio de inserción debe permanecer totalmente expuesto para permitir una visualización y vigilancia continua.*

Catéteres Venosos Centrales y Urinarios

Catéter Venoso Central

- **Inserción Dirigida:** Con guía ecográfica y técnica de barrera máxima estéril.
- **Fijación Pasiva:** Sin tensión y evitando colocar adhesivos sobre articulaciones o eminencias óseas.
- **Vigilancia Continua:** Inspección diaria exhaustiva del sitio de punción, valorando signos de perfusión o isquemia distal.

Catéter Urinario

- **Sujeción Anatómica:** Fijación dócil sobre la cara interna del muslo o la región inferior del abdomen.
- **Sistema Cerrado:** Preservar la hermeticidad del circuito sin generar tracción sobre la uretra.
- **Prevención de Retiros:** Asegurar el trayecto para blindarlo contra tirones o movimientos involuntarios del lactante.

Reglas de Aplicación Clínica

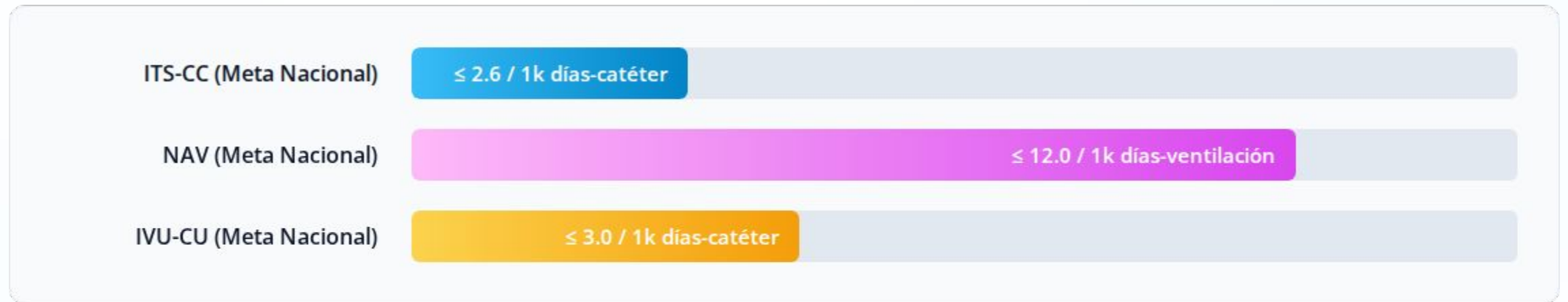
✗ Queda Prohibido

- ✗ Utilizar materiales rígidos, agresivos, cintas adhesivas industriales o de uso general.
- ✗ Fijar directamente sobre cabello, vello, mucosas, cicatriz umbilical o articulaciones de flexión.
- ✗ Cubrir u ocultar el punto exacto de inserción de cualquier dispositivo invasivo.
- ✗ Utilizar soluciones antisépticas yodadas para la curación del muñón.

✓ Es Obligatorio

- ✓ Establecer revisiones sistemáticas cada turno (evaluando coloración, temperatura y llenado capilar).
- ✓ Realizar retiros de manera extremadamente suave (con agua tibia o aceite mineral si hay adherencia).
- ✓ Incorporar estas directrices técnicas en los Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) oficiales.
- ✓ Registrar de forma inmediata en la hoja de enfermería cada manipulación y estado cutáneo.

Relación con las Metas Nacionales de IAAS



Cadena Crítica de Infección: Fijación Deficiente → Desplazamiento del Dispositivo → Manipulación Frecuente → Colonización Bacteriana → Incremento de Tasas de ITS-CC / NAV / IVU-CU.

Órganos de vigilancia responsables: **COVEPCIAAS, COA**, médicos especialistas y personal de enfermería especializada.

| Lista de Verificación de Seguridad

- ✓ **Selección de Materiales:** ¿Los insumos a emplear son hipoalergénicos, suaves y adecuados para la edad gestacional o peso del lactante?
- ✓ **Visibilidad Total:** ¿El punto exacto de inserción del dispositivo permanece 100% visible sin necesidad de retirar la fijación principal?
- ✓ **Presión y Tensión Cero:** ¿La fijación carece de compresión o tensión excesiva que comprometa la circulación periférica?
- ✓ **Protección del Occipucio y Extremidades:** ¿Se ha verificado que no exista presión residual sobre orejas, narinas, cuello o extremidades?
- ✓ **Monitorización y Registro:** ¿Se evaluó el estado tisular local al inicio del turno y quedó registrado de manera correcta en el expediente?

Garantizar la sujeción segura es un pilar fundamental en la calidad de la atención neonatal.

PROY-NOM-045-SSA-2026

Introduce criterios pediátricos y neonatales específicos que antes eran inexistentes o puramente genéricos.

PAQUETES PREVENTIVOS

La fijación correcta deja de ser un procedimiento aislado; forma parte de la estrategia nacional obligatoria contra IAAS.

IMPACTO CLÍNICO

Su aplicación sistemática disminuye de forma drástica lesiones mecánicas, estancias prolongadas y morbilidad infecciosa.

ESTANDARIZACIÓN (POE)

Es indispensable la capacitación continua del equipo interdisciplinario y la auditoría clínica de los dispositivos.

-
- Proyecto de Norma Oficial Mexicana . Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud.
 - Panorama Epidemiológico de las IAAS, Marzo 2026. Secretaría de Salud, Dirección General de Epidemiología. México.